

样，因而 PSRT 与窦速难于区别。PSRT常突然发生，突然中止，频率常在 100~160 次/分，常持续很短时间。

QRS波宽的心动过速

除（正路）逆传型房室反复性心动过速外，其他各型 PSVT，当不伴有束支阻滞其 QRS 波是窄的。然而，如果室上速伴功能性或原有束支阻滞，则 QRS 增宽，此时必须与室速相鉴别。下面几点对诊断可能提供帮助：（1）如果心动过速由一个房性早搏引起，则很可能为室上性；（2）在没有能使 QRS 增宽的药物作用下，如果 QRS 波明显增宽（>0.14 秒），则

心动过速很可能是室性；（3）电轴向上有利于诊断室速，而电轴向右有利于诊断室上速；（4）出现融合搏动高度提示为室速；（5）出现房室分离也高度提示为室速；（6）心前导联 QRS 波的图形呈一致性者，提示为室速；（7）V<sub>1</sub> 导联 QRS 形态是三相型呈右束支阻滞图形（RSR'）提示为室上速，若呈单相或双相型（qR 或 Rs）则提示为室速。

多数病例要确定其心动过速系室性或室上性源者必须作心内心电图检查。

体表心电图上鉴别各型 PSVT 有用的线索归纳于下表。

PSVT 体表心电图的鉴别诊断

| 分 类                | QRS波形态 | 频率次/分   | I、II导联P波形态          | 说 明                     |
|--------------------|--------|---------|---------------------|-------------------------|
| 房室结折返性心动过速         | 窄      | 140~200 | 逆P，通常不能辨识           | CSM 可中止发作               |
| 非典型房室结折返性心动        | 窄      | 100~150 | 逆P 出现较晚，R~P间期延长     | CSM 可中止发作               |
| （正路）前传型房室反复性心动过速   | 窄      | 150~240 | 逆P出现在QRS波之后，R~P间期短  | 伴有房室阻滞时，可排除之。           |
| （正路）逆传型反复性心动过速     | 宽      | 150~240 | 逆P出现在QRS波之前，P-R间期短  | 同 上                     |
| 结室旁路束（Mahaim 纤维）   | 宽，LBBB | 140~200 | P 波位置和形态多变          | 窦心律时PR正常有delta波         |
| 房内折返性心动过速（IART）    | 窄      | 100~150 | P 波QRS波前，形态逐搏改变     | CSM 可引起房室阻滞而不中止发作。      |
| 房性自律性心动过速          | 窄      | 100~180 | P 波在QRS波前，P 波呈直立或倒置 | 舒张晚期房性早搏引起；频率逐步增加（加温现象） |
| 阵发性反复性窦性心动过速（PSRT） | 窄      | 100~160 | P 波在QRS波前，形态与窦律一致   | 突然发作，突然中止。              |

（宋有城节译 刘力生校）

乙胺碘呋酮药物相互作用

〔Marcus F I 等：Am Heart J 1983，106（4 Part 2）：924（英文）〕

乙胺碘呋酮药物相互作用很重要，因为它与许多心血管药物如华法令、狄高辛、奎尼丁、普鲁卡因胺等并用，可使这些药物动力学方面产生明显的影响，与另一些药物如β阻滞剂，钙拮抗剂并用，会出现血液动力学和电生理的相互作用。

用。

乙胺碘呋酮和华法令相互作用

1979年Simpson首先报告乙胺碘呋酮可增强华法令的抗凝作用，相继有这两种药物并用引

起7例出血的报告。应用华法令的患者，再用乙胺碘呋酮治疗，凝血酶原时间可成倍增长。这个作用最早出现在乙胺碘呋酮用后3~4天，但也可迟至三周者。它对华法令活性的影响，即使停药，也可持续至数周或数月。

临床上若上述二药并用，建议华法令的维持量减少1/3~1/2，且对凝血酶原时间进行监视，同样，它也影响肝素的活性。

## 乙胺碘呋酮与狄高辛相互作用

1981年Moysey等观察服用狄高辛的7例患者，并用乙胺碘呋酮后，所有患者狄高辛血浆浓度进行性增加，平均增加69%，后来一些研究大多支持这个结论，但也有少数不一致的结论。乙胺碘呋酮200mg每日三次，24小时内血浆狄高辛浓度即可增加，且6~7天内直线上升，然后呈一平台状。7例中有4例出现狄高辛中毒症状，包括有窦停，胃肠症状和“神经中毒”。由于乙胺碘呋酮的抗心律失常作用，实际上这四例中无一例发生房或室性逸搏。

相互作用的机理尚不明了。相互作用的时间始于24小时之内，约7天达稳定状态，这提示其机理可能是乙胺碘呋酮使狄高辛肾排泄减少，或对狄高辛肾外排泄和组织转移的减少等有关。

我们有40例的经验，当乙胺碘呋酮与狄高辛并用，后者血浆浓度成倍增长，二例发生狄高辛中毒症状，血浆狄高辛浓度大于2ng/ml，一例恶心，另一例视力障碍。根据我们和其他人的经验，当二药联合用药时，建议狄高辛应减量一半。

## 乙胺碘呋酮与抗心律失常药物相互作用

乙胺碘呋酮相互作用最危险的与其他抗心律失常药物并用，诸如奎尼丁、双异丙吡胺、慢心律、安搏律定、普鲁卡因胺。药物产生的扭转型

室速，已报告的有乙胺碘呋酮与奎尼丁结合、双异丙吡胺或慢心律等，每例扭转型室速发作前均有Q-T间期明显延长。乙胺碘呋酮可使奎尼丁血浆浓度增加，自然对Q-T间期延长有追加作用。

乙胺碘呋酮与I类药物（膜抑制剂）联合应用时，后者应减为半量。通常应避免与I类药物并用或谨慎应用。

## 乙胺碘呋酮与β阻滞剂和钙离子拮抗剂的相互作用

乙胺碘呋酮有阻滞交感活力的作用，但并非对β受体竞争拮抗。乙胺碘呋酮减低窦房结自律性和延长房室结的不应期。在窦性心动过缓、病窦综合征或部分房室阻滞的患者，当乙胺碘呋酮与β阻滞剂或钙拮抗剂并用，更减慢窦律，加重房室阻滞，偶有引起严重的结果。如Derrida描写一个患者心房扑动，虽用乙胺碘呋酮和洋地黄治疗，但心室率仍很快，给心得安口服一次，患者心脏停搏，心电图示完全缺乏心室激动，幸运的是患者对异丙肾上腺素滴注有效。另一例为急性心肌梗塞，因持续疼痛静脉给予乙胺碘呋酮，24小时后仍持续疼痛，停用乙胺碘呋酮，给口服心得安二次，一个半小时后，发生显著的心动过缓，且立即发生室颤，用电除颤治疗成功。

乙胺碘呋酮与β阻滞剂或钙拮抗剂结合应用要慎重，特别是疑有窦房结功能不全，如心动过缓，病窦综合征；或有部分房室阻滞者。

总之，乙胺碘呋酮药物相互作用，除上述之外，还得继续研究去发现。它重要在肝脏代谢，故有可能妨害肝的药物代谢。另外与狄高辛相互作用于肾脏，提示乙胺碘呋酮可干扰肾对一些药物的清除。为了防止心血管药物并用后的中毒影响，临床医生必须警惕这些较多的相互作用。

（牛列智节译 穆依仁校）